

TEMA 3.33 • OBSTETRICIA

Manejo de la Muerte de un Gemelo

PERFIL EUNACOM 1.03.33
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Manejo de la Muerte de un Gemelo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Este es uno de los temas más **controvertidos** en obstetricia — no hay consenso claro en la literatura. El enfoque EUNACOM es orientador, no dogmático.

Fisiopatología según corionicidad

Monocorial

- Existen **vasos comunicantes** entre ambos gemelos - Al morir uno, la sangre se redistribuye **de inmediato** hacia el gemelo fallecido - El daño al gemelo sobreviviente es **instantáneo** — interrumpir no lo revierte - Conclusión: **"Interrumpir no sirve"** (el daño ya está hecho si se produjo)

Bicorial

- No hay comunicación vascular directa - Riesgo menor, pero no despreciable - Puede haber causa de base que explique ambas muertes (infección, preeclampsia, etc.) - **Siempre buscar causa del óbito**

Manejo General (ante muerte ya ocurrida)

Paso 1: Evaluación

TABLA 3.33.1: EVALUACIÓN VS HERRAMIENTAS	
EVALUACIÓN	HERRAMIENTAS
Estado del gemelo sobreviviente	Perfil biofísico, Doppler
Estado materno	Buscar causa del óbito (infección, PE, etc.)

Paso 2: Conducta según resultado

TABLA 3.33.2: ESTADO DE MADRE E HIJO SOBREVIVIENTE VS CONDUCTA	
ESTADO DE MADRE E HIJO SOBREVIVIENTE	CONDUCTA
Ambos bien	Conducta expectante — no interrumpir
Cualquiera mal (causa identificada, ej. infección)	Interrumpir

Paso 3: Según EG y corionicidad

TABLA 3.33.3: EG VS CORIONICIDAD		
EG	CORIONICIDAD	CONDUCTA
< 26 semanas	Cualquiera	Expectante (inviabilidad fetal)
≥ 26 semanas	Bicorial	Expectante (riesgo menor)
≥ 26 semanas	Monocorial	Controversial — expectante vs. interrumpir (discutir caso a caso)

Caso especial: Muerte INMINENTE de uno de los gemelos (aún vivo)

> Cuando **todavía no ha muerto** pero se prevé que fallecerá (ej. patrón sinusoidal, malformación letal)

En este escenario **sí se puede actuar antes** de que ocurra el daño.

TABLA 3.33.4: EG VS CORIONICIDAD		
EG	CORIONICIDAD	CONDUCTA
< 26 semanas	Cualquiera	Expectante
≥ 26 semanas	Bicorial	Expectante (riesgo menor)
≥ 26 semanas	Monocorial	Interrumpir (para salvar al sobreviviente antes del daño)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave del razonamiento: - Si el gemelo **ya murió** → el daño al sobreviviente ya ocurrió (en monocorial) → interrumpir no sirve → expectante - Si el gemelo **está a punto de morir** → aún se puede prevenir el daño → interrumpir si ≥ 26 sem y monocorial
El punto de viabilidad de los 26 semanas es fundamental en todos los escenarios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Manejo de la Muerte de un Gemelo: Cualquiera | Expectante (inviabilidad fetal) | ≥ 26 semanas | Bicorial | Expec... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de la Muerte de un Gemelo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fisiopatología según corionicidad
- Monocorial
- Bicorial
- Manejo General (ante muerte ya ocurrida)
- Paso 1: Evaluación
- Paso 2: Conducta según resultado
- Paso 3: Según EG y corionicidad

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LA MUERTE DE UN GEMELO)

PREGUNTA 1

En relación a Manejo de la Muerte de un Gemelo: Cualquiera | Expectante (inviabilidad fetal) | ≥ 26 semanas | Bicorial | Expec... ¿cuál es la conducta correcta?

- ☐ A) El diagnóstico de Manejo de la Muerte de un Gemelo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- ☐ B) El manejo inicial de Manejo de la Muerte de un Gemelo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- ☐ C) Todo paciente con Manejo de la Muerte de un Gemelo requiere hospitalización inmediata
- ☐ D) El tratamiento de Manejo de la Muerte de un Gemelo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- ☐ E) El seguimiento de Manejo de la Muerte de un Gemelo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Manejo de la Muerte de un Gemelo?

- ☐ A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- ☐ B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- ☐ C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- ☐ D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- ☐ E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Manejo de la Muerte de un Gemelo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- ☐ A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- ☐ B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- ☐ C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- ☐ D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- ☐ E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: MANEJO DE LA MUERTE DE UN GEMELO

⚠ Este es uno de los temas más controvertidos en obstetricia — no hay consenso claro en la literatura. El enfoque EUNACOM es orientador, no dogmático. ⚠